

La santé en tant que droit humain : analyse de l'exemple canadien face au VIH et aux inégalités de santé

L'inégalité dans l'accès aux soins de santé est un problème qui continue de se poser au Canada, en particulier pour les peuples autochtones. Dans son article "The Embodiment of Inequality: Health Disparities in Aboriginal Canada", Naomi Adelson explore les disparités en matière de santé entre les peuples autochtones et non autochtones, ainsi que les facteurs qui contribuent à ces disparités. L'auteur note que l'inégalité en matière de santé est souvent liée à des facteurs sociaux et économiques tels que la pauvreté, le manque de logement adéquat, la discrimination et les traumatismes historiques. Ces facteurs sont encore exacerbés par le racisme systémique qui continue d'être présent dans le système de santé canadien.

Le professeur Michael Marmot a déclaré: «Les inégalités de pouvoir, d'argent et de ressources donnent lieu à des inégalités dans les conditions de vie quotidiennes, ce qui conduit à des inégalités en matière de santé». Cette citation montre l'importance des déterminants sociaux de la santé et les défis qu'ils représentent pour la promotion mondiale d'un développement durable. En effet, les déterminants sociaux de la santé doivent être compris comme un droit à jouir de diverses installations, biens, services et conditions nécessaires pour réaliser le plus haut niveau possible de santé. Cependant, ces droits universels et ces dispositions inaliénables s'opposent indéniablement à un accès exclusif à la santé et aux privilèges de certains individus sur d'autres. La santé est le troisième objectif de développement durable annoncé par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015. Ces 17 principes sont des objectifs qui devraient être atteints en 2030 et "Bonne santé et

bien-être" est inclus dans la liste, ce qui explique l'importance de la santé pour le développement durable, défini comme le développement qui répondra aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Néanmoins, ces inégalités montrent que l'opposition entre la théorie et la pratique est extrêmement importante à examiner pour cette question spécifique. Nous répondrons donc dans cet essai à la question suivante: Comment les déterminants sociaux de la santé concernant le VIH dans les communautés autochtones du Canada sont-ils un excellent exemple d'un dilemme mondial qui entrave les perspectives de développement durable? Tout d'abord, nous discuterons de la théorie et de l'importance de la santé en tant qu'objectif de développement durable. Ensuite, nous opposerons la théorie à sa réalité et à sa pratique grâce à l'analyse empirique et comparative des disparités en matière de VIH entre les communautés canadiennes.

Dans cette section, nous exposerons la théorie de la santé en tant que droit humain à travers des exemples concrets au Canada, un pays où le SIDA était considéré comme un problème fondamental. En 1966, dans le douzième article du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il était stipulé que chacun avait le droit de jouir du «plus haut niveau possible de santé physique et mentale» (INTD, 10.1). Ce pacte montre à lui seul la compréhension de la santé en tant que droit universel et, surtout, une disposition inaliénable dont on ne peut priver les êtres humains. Il semble donc que la théorie concernant la santé repose sur des principes moraux universels garantis par le droit international.

En effet, l'Organisation mondiale de la santé, un organe des Nations Unies, a fait de la santé sa priorité absolue en tant que droit humain sans «distinction de race, de religion, de croyance politique, de condition économique ou sociale».

En conséquence, les inégalités de santé reflètent les inégalités de pouvoir, d'argent et de ressources, qui sont des facteurs qui ont une incidence sur les conditions de vie quotidiennes et, par conséquent, sur la santé. Les déterminants sociaux de la santé doivent être compris comme un droit à jouir de diverses installations, biens, services et conditions nécessaires pour réaliser le plus haut niveau de santé possible. Toutefois, ces droits universels et ces dispositions inaliénables s'opposent incontestablement à l'accès exclusif à la santé et aux privilèges de certains individus sur d'autres.

Avec cette approche, on a tendance à se concentrer davantage sur la distribution, c'est-à-dire la fréquence des modèles et de leurs déterminants. Cette approche crée un angle mort en omettant l'aspect social de la santé, sur lequel nous reviendrons dans la deuxième partie de cet essai. De plus, le marché et les corporations pharmaceutiques ont également tendance à être prioritaires par rapport à l'approche sociale, en particulier en ce qui concerne le VIH, en raison du coût de son traitement. Étant donné que la quantité de thérapie semble être, en théorie, le meilleur moyen d'atteindre ce troisième objectif de développement durable d'ici 2030, la production de médicaments et les aspects du marché sont tout aussi importants pour l'élément théorique, même s'ils peuvent contribuer à renforcer les inégalités socio-économiques.

L'exemple du Canada et de la manière dont le gouvernement et les décideurs politiques ont traité le VIH renforce notre argumentation. Au fait, il est essentiel de rappeler que le virus de l'immunodéficience humaine est le virus qui cause le SIDA. Le VIH endommage le système immunitaire, rendant plus facile pour une personne de tomber malade, et se transmet par le sang et donc les rapports sexuels ou l'utilisation de drogues injectables. En 2018, on estime que 62 050

personnes vivaient avec le VIH au Canada, et ce nombre continue d'augmenter en raison de la transmission continue et de l'augmentation de la longévité des personnes vivant avec cette maladie. Le Canada a endossé la stratégie sectorielle mondiale de l'ONUSIDA et de l'Organisation mondiale de la santé sur le VIH pour générer de l'élan en vue d'éliminer cette maladie comme une menace pour la santé publique d'ici 2030. Par conséquent, les objectifs et les cibles «90-90-90» ont été inventés pour déclarer que d'ici 2020, 90% des personnes affectées auront un statut reconnu, 90% des personnes diagnostiquées recevront un traitement et 90% des personnes sous traitement atteindront une suppression virale (Gouvernement du Canada). Lorsque ces trois objectifs auront été atteints, au moins 73% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne seront plus considérées comme virales, ce qui permettra au monde et au Canada d'éliminer l'épidémie de SIDA d'ici 2030. Par conséquent, cet exemple montre que l'éradication du VIH et donc la promotion de la santé sont considérées comme l'un des objectifs de développement durable les plus importants à atteindre d'ici 2030.

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les inégalités de santé qui existent au Canada et dans le monde. Dans leur article "The COVID-19 Pandemic and Health Inequalities", Claire Bambra et ses collègues examinent l'impact disproportionné de la pandémie sur les populations les plus vulnérables. Les auteurs notent que les populations marginalisées ont un accès limité aux soins de santé et sont plus susceptibles de travailler dans des emplois à faible rémunération, exposant ainsi leur santé à des risques plus élevés. Les auteurs soulignent également que les gouvernements doivent prendre des mesures pour réduire les inégalités de santé et s'attaquer aux facteurs sociaux et économiques qui les sous-tendent.

Dans son livre "Infections and Inequalities: The Modern Plagues", Paul Farmer explore les liens entre la pauvreté, les inégalités de santé et les maladies infectieuses. L'auteur souligne que les populations les plus pauvres sont souvent les plus touchées par les maladies infectieuses en raison de leur manque d'accès aux soins de santé, de leur exposition à des environnements insalubres et de leur manque de moyens pour se protéger contre les infections. Farmer plaide pour une approche plus globale de la santé publique qui prend en compte les facteurs sociaux et économiques qui sous-tendent les inégalités de santé.

Pour lutter contre les inégalités de santé, il est important de comprendre la charge de la maladie dans différents groupes de population. Dans leur article "Towards a New Framework for Measuring Burden of Disease in Canada", Marpa Isfeld et ses collègues proposent un nouveau cadre pour mesurer la charge de la maladie qui prend en compte les différences entre les groupes de population. Les auteurs soulignent que les inégalités en matière de santé doivent être prises en compte dans la planification des politiques de santé et dans la distribution des ressources de santé.

Enfin, le rapport "HIV in Canada: Surveillance Highlights" de l'Agence de la santé publique du Canada met en évidence les inégalités en matière de VIH/sida au Canada. Le rapport note que les populations autochtones, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes vivant dans la pauvreté sont plus susceptibles d'être infectées par le VIH. Il souligne également l'importance de s'attaquer aux facteurs sociaux et économiques qui entretiennent les inégalités de santé afin de réduire les disparités dans les résultats observés. Cette approche est cruciale pour les populations autochtones du Canada, qui ont subi des taux élevés de mortalité et de maladie dus à leur situation de pauvreté, de marginalisation et de manque d'accès à un système de santé de qualité. Naomi Adelson (2005) a souligné que les Inuits et les Premières Nations sont confrontés à des inégalités de santé considérables, y compris des taux plus élevés de diabète, de

maladies cardiovasculaires, de tuberculose et d'infections des voies respiratoires. La pandémie de COVID-19 a exacerbé ces inégalités, comme l'ont noté Bambra et ses collègues (2020). Les personnes appartenant à des groupes socialement défavorisés, y compris les peuples autochtones, ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie en raison de leur plus grande exposition au virus et de leurs conditions de vie précaires.

Paul Farmer (2001) a également identifié l'impact des inégalités sociales sur la santé, en particulier dans les pays à faible revenu touchés par les épidémies. Les inégalités économiques peuvent empêcher les populations de se protéger contre les maladies et de recevoir les soins de santé nécessaires en cas de maladie. Cette situation est également présente au Canada, où les communautés autochtones n'ont souvent pas accès à des soins de santé de qualité en raison de la distance géographique, du manque de ressources et de la discrimination systémique. Selon Isfeld et ses collègues (2022), une nouvelle approche pour mesurer le fardeau des maladies au Canada devrait tenir compte des inégalités socio-économiques et environnementales qui influencent les résultats de santé. Cela permettrait de mieux comprendre l'ampleur des disparités de santé et de mettre en place des interventions appropriées pour les populations les plus vulnérables.

En outre, le VIH est une maladie qui continue de toucher les communautés autochtones au Canada. Selon les données de l'Agence de la santé publique du Canada (2021), les Autochtones représentent près de 10% des nouveaux cas de VIH au pays, malgré le fait qu'ils ne constituent que 5% de la population canadienne. Les taux d'infection sont plus élevés chez les femmes autochtones et les jeunes de 15 à 29 ans. Ces chiffres soulignent l'importance de reconnaître les inégalités structurelles qui participent activement à la propagation du VIH et de mettre en place des programmes de prévention adaptés aux besoins des communautés autochtones.

Il est essentiel de mettre en place des politiques et des mesures pour lutter contre les inégalités en santé, en particulier pour les populations autochtones. Comme l'a souligné Adelson (2005), les inégalités en santé entre les populations autochtones et non autochtones sont le résultat de facteurs sociaux, économiques et historiques profondément ancrés. Les politiques et les programmes doivent donc prendre en compte ces facteurs, ainsi que les expériences et les perspectives des peuples autochtones eux-mêmes, afin de parvenir à des résultats durables.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la manière dont les inégalités en santé peuvent affecter de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables. Par exemple, les peuples autochtones ont été touchés de manière disproportionnée en raison de leur situation économique et de santé précaire ainsi que de la négligence historique de leur bien-être. Pour lutter contre ces inégalités, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques et des programmes qui reconnaissent ces facteurs et qui sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des populations autochtones. Par exemple, des programmes de vaccination ciblés peuvent être mis en place pour assurer une meilleure protection aux populations autochtones.

La lutte contre les inégalités en santé est essentielle pour lutter contre les maladies infectieuses telles que le VIH. Les populations marginalisées sont souvent les plus touchées par ces maladies en raison de facteurs tels que la pauvreté, l'accès limité aux soins de santé et les niveaux élevés de stress et de discrimination. Pour lutter contre ces maladies, il est donc nécessaire de mettre en place des politiques et des programmes qui visent à réduire ces inégalités. Par exemple, des campagnes de sensibilisation pourraient être organisées pour informer les populations marginalisées sur les moyens de se protéger contre le VIH.

Le rapport d'Isfeld et al. (2022) souligne également l'importance de mesurer l'impact des maladies sur les populations les plus touchées. En mesurant l'impact de la maladie sur les populations

vulnérables, il est possible de mettre en évidence les inégalités en santé et de concevoir des politiques et des programmes pour y remédier. Par exemple, des enquêtes de santé pourraient être menées pour collecter des données sur la santé des populations vulnérables et identifier les domaines dans lesquels des interventions spécifiques sont nécessaires. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour élaborer des programmes de santé publique plus efficaces et plus équitables.

En conclusion, la santé est un droit humain fondamental qui doit être garanti sans distinction de race, de religion, de croyance politique, de condition économique ou sociale. Les inégalités de santé reflètent les inégalités de pouvoir, d'argent et de ressources, qui sont des facteurs ayant une incidence sur les conditions de vie quotidiennes et, par conséquent, sur la santé. Pour atteindre le plus haut niveau possible de santé, il est nécessaire de comprendre les déterminants sociaux de la santé, qui sont des droits à jouir de diverses installations, biens, services et conditions nécessaires. Les gouvernements et les décideurs politiques ont un rôle crucial à jouer pour garantir l'accès équitable à la santé, comme le démontre l'exemple du Canada dans sa lutte contre le VIH et l'objectif de l'éradication du SIDA d'ici 2030. Cependant, il est important de souligner que l'approche basée sur la distribution et la production de médicaments ne doit pas faire passer les intérêts du marché et des corporations pharmaceutiques avant ceux de la santé publique. La pandémie de COVID-19 a également mis en évidence les inégalités de santé existantes, en particulier pour les populations les plus vulnérables. En fin de compte, il est essentiel de travailler ensemble pour garantir le droit à la santé pour tous, afin de créer une société plus juste et plus équitable.

(2 413 mots)

Arthur Barrier

Bibliographie :

Adelson, Naomi. 2005. "The Embodiment of Inequality: Health Disparities in Aboriginal Canada." Canadian Journal of Public Health 96: 45-61.

Bambra, Claire et al.. "The COVID-19 Pandemic and Health Inequalities." Journal of Epidemiology and Community Health, U.S. National Library of Medicine, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32535550/>.

Farmer, Paul. "Infections and Inequalities : The Modern Plagues". University of California Press, 2001, pp. 1-6 (Introduction), <https://www.ucpress.edu/book/9780520229136/infections-and-inequalities>.

Isfeld, Marpa et al. "Towards a New Framework for Measuring Burden of Disease in Canada". National Collaborating Centre for Infectious Diseases, May 2022, pp. 1-36. https://nccid.ca/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/Burden-of-Disease-Concept-Paper_ENG.pdf.

HIV in Canada: Surveillance Highlights, Public Health Agency of Canada 2021, <https://www.canada.ca/en/publichealth/services/publications/diseases-conditions/hiv-2020-surveillance-highlights.html>